

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO

1. NOME DO MEDICAMENTO

Brufen 400 mg cápsulas moles

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Cada cápsula mole contém 400 mg de ibuprofeno

Excipiente(s) com efeito conhecido:

Cada cápsula mole contém 72,4 mg de sorbitol, líquido, parcialmente desidratado (E 420).

Lista completa de excipientes, ver secção 6.1.

3. FORMA FARMACÊUTICA

Cápsula mole

Cápsulas moles de gelatina com forma oval (aproximadamente 16 mm x 10 mm), incolores ou ligeiramente amarelas e cheias com uma solução transparente.

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS

4.1 Indicações terapêuticas

Brufen 400 mg é indicado em adultos e adolescentes com peso igual ou superior a 40 kg (com idade igual e superior a 12 anos) para o tratamento sintomático de curta duração de dores ligeiras a moderadas, como cefaleias, dores de dentes, dores menstruais e febre.

4.2 Posologia e modo de administração

Para administração oral de curto prazo.

Os efeitos indesejáveis podem ser minimizados utilizando a menor dose eficaz durante o menor período de tempo necessário para controlar os sintomas (ver secção 4.4).

Posologia

Adultos e adolescentes com peso igual ou superior a 40 kg (com idade igual e superior a 12 anos).

A dose única recomendada é de 400 mg (1 cápsula), que pode ser tomada até 3 vezes por dia, se necessário.

O intervalo entre as doses deve ser de, pelo menos, 6 horas.

A dose diária máxima de 1200 mg não deve ser excedida num período de 24 horas.

População pediátrica

Brufen 400 mg não se destina a adolescentes com peso inferior a 40 kg ou crianças com idade inferior a 12 anos.

Idosos

Os idosos apresentam um risco aumentado de reações adversas com consequências graves. Se um AINE for considerado necessário, deve ser utilizada a dose eficaz mais baixa e pelo período de tempo mais curto possível. O doente deve ser monitorizado regularmente quanto a hemorragias GI durante a terapêutica com AINEs.

Insuficiência renal

Deve ter-se cuidado em doentes com insuficiência renal ligeira a moderada. A dose deve ser mantida tão baixa quanto possível e a função renal deve ser monitorizada (ver secção 4.4). O medicamento é contraindicado em doentes com insuficiência renal grave (ver secção 4.3).

Insuficiência hepática

Deve ter-se cuidado em doentes com insuficiência hepática ligeira a moderada. A dose deve ser mantida tão baixa quanto possível (ver secção 4.4). O medicamento é contraindicado em doentes com insuficiência hepática grave (ver secção 4.3).

Modo de administração

Para administração oral.

A cápsula mole deve ser tomada com um copo de água e não deve ser mastigada.

Recomenda-se que os doentes com estômago sensível tomem ibuprofeno com alimentos.

Duração do tratamento

Em adolescentes entre os 12 e os 18 anos de idade, se este medicamento for necessário durante mais de 3 dias, ou se os sintomas se agravarem, deve ser consultado um médico.

Em adultos, se a dor durar mais de 4 dias, a febre persistir mais de 3 dias ou se a dor ou febre se agravarem ou surgirem outros sintomas, a situação clínica deve ser avaliada.

4.3 Contraindicações

- Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1.
- Histórico de reações de hipersensibilidade (por exemplo broncoespasmo, asma, rinite, angioedema ou urticária) em resposta ao ácido acetilsalicílico ou a outros anti-inflamatórios não esteroides.
- Histórico ou existência de úlcera péptica/hemorragia ativa recorrentes (dois ou mais episódios distintos de ulceração ou hemorragia comprovada).
- Histórico de hemorragia ou perfuração gastrointestinal relacionada com terapêutica anterior com AINEs.
- Insuficiência renal grave.
- Insuficiência hepática grave.
- Insuficiência cardíaca grave (classe IV da Associação cardíaca de NY).
- Último trimestre da gravidez (ver secção 4.6).
- Perturbações não esclarecidas na formação do sangue.
- Hemorragia cerebrovascular ou outra hemorragia ativa.
- Condições que envolvem o aumento da tendência para ter hemorragias.
- Desidratação grave (por exemplo causada por vômitos, diarreia ou ingestão insuficiente de líquidos).

4.4 Advertências e precauções especiais de utilização

Os efeitos indesejáveis podem ser minimizados utilizando a menor dose eficaz durante o menor período de tempo necessário para controlar os sintomas (ver secção 4.2 e informação sobre os riscos GI e cardiovasculares abaixo).

Riscos gastrointestinais

Foram notificados casos de hemorragia, ulceração ou perfuração GI, que podem ser fatais, com todos os AINEs, em qualquer momento durante o tratamento, com ou sem sintomas de alerta ou histórico de eventos gastrointestinais.

O risco de hemorragia, ulceração ou perfuração GI é maior com doses mais elevadas de AINEs, em doentes com histórico de úlceras, particularmente em caso de complicações com hemorragia ou perfuração (ver secção 4.3) e em idosos. Estes doentes devem iniciar o tratamento com a dose mais baixa disponível.

Deve ser considerada terapêutica de associação com agentes protetores (por exemplo misoprostol ou inibidores da bomba de prótons) para estes doentes, e também para doentes que requeiram uma dose baixa concomitante de ácido acetilsalicílico ou outros medicamentos que possam aumentar o risco gastrointestinal (ver abaixo e secção 4.5).

Os doentes com um histórico de toxicidade GI, particularmente idosos, devem comunicar quaisquer sintomas abdominais não habituais (especialmente hemorragia GI), sobretudo nas fases iniciais do tratamento.

É aconselhada precaução em doentes a tomar concomitantemente outros medicamentos que possam aumentar o risco de ulceração ou hemorragia, como corticosteroides orais, anticoagulantes, como a varfarina, inibidores seletivos da recaptação da serotonina ou medicamentos anti-agregantes plaquetários, como o ácido acetilsalicílico (ver secção 4.5).

Em caso de hemorragia ou ulceração GI em doentes a tomar ibuprofeno, o tratamento deve ser interrompido de imediato (ver secção 4.3).

Os AINEs devem ser administrados com precaução em doentes com histórico de doença gastrointestinal (colite ulcerosa, doença de Crohn) na medida em que a sua condição pode ser exacerbada (ver secção 4.8).

Riscos cardiovasculares e cerebrovasculares

É necessária precaução (conversa com um médico ou farmacêutico) antes de iniciar o tratamento em doentes com histórico de hipertensão e/ou insuficiência cardíaca, pois foram observados retenção de líquidos, hipertensão e edema em associação com a terapêutica com AINEs.

Estudos clínicos sugerem que a utilização de ibuprofeno, particularmente em doses elevadas (2400 mg/dia), poderá estar associado a um pequeno aumento do risco de eventos trombóticos arteriais (por exemplo enfarte do miocárdio ou AVC). De um modo geral, os estudos epidemiológicos não sugerem que uma dose baixa de ibuprofeno (por exemplo ≤ 1200 mg/dia) esteja associada a um aumento do risco de eventos trombóticos arteriais.

Os doentes com hipertensão arterial não controlada, insuficiência cardíaca congestiva (NYHA II-III), doença isquémica cardíaca estabelecida, doença arterial periférica e/ou doença cerebrovascular apenas devem ser tratados com ibuprofeno após cuidadosa avaliação e devem ser evitadas doses elevadas (2400 mg/dia).

É necessária uma cuidadosa avaliação antes de iniciar o tratamento de longa duração de doentes com fatores de risco para eventos cardiovasculares (por exemplo hipertensão, hiperlipidemia, diabetes mellitus, hábitos tabágicos), particularmente se forem necessárias doses elevadas de ibuprofeno (2400 mg/dia).

Têm sido notificados casos de síndrome de Kounis em doentes tratados com Brufen.

A síndrome de Kounis caracteriza-se por sintomas cardiovasculares secundários a uma reação alérgica ou de hipersensibilidade associada à constrição das artérias coronárias e potencialmente conducente a um enfarte do miocárdio.

Riscos dermatológicos

Reações adversas cutâneas graves (RACG)

Reações adversas cutâneas graves (RACG), incluindo dermatite esfoliativa, eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson (SSJ), necrólise epidérmica tóxica (NET), reação a fármacos com eosinofilia e sintomas sistémicos (síndrome DRESS) e pustulose exantematosa generalizada aguda (PEGA), que podem ser potencialmente fatais ou fatais, foram notificadas em associação com a utilização de ibuprofeno (ver secção 4.8). A maioria destas reações ocorreu no primeiro mês.

Se surgirem sinais e sintomas sugestivos destas reações, o ibuprofeno deve ser imediatamente descontinuado e deve ser considerado um tratamento alternativo (conforme adequado).

Insuficiência renal e (ou) hepática

O ibuprofeno deve ser utilizado com precaução em doentes com antecedentes de doença hepática ou renal e, especialmente, durante o tratamento simultâneo com diuréticos, uma vez que se deve ter em conta que a inibição das prostaglandinas pode causar retenção de líquidos e deterioração da função renal. Se administrado nestes doentes, a dose de ibuprofeno deve ser mantida tão baixa quanto possível e a função renal deve ser monitorizada regularmente (ver secções 4.3 e 4.8).

Em caso de desidratação, é necessário garantir uma ingestão suficiente de líquidos. Existe um risco de insuficiência renal em adolescentes desidratados.

Em geral, a utilização regular de analgésicos, especialmente a associação de diferentes substâncias analgésicas, pode causar lesões renais duradouras, com o risco de insuficiência renal (nefropatia analgésica). Os idosos e os doentes com insuficiência renal, insuficiência cardíaca, disfunção hepática e aqueles que são tratados com diuréticos ou inibidores da ECA apresentam um risco elevado desta reação. A interrupção da terapêutica com AINEs resulta normalmente na recuperação do estado pré-tratamento.

Tal como acontece com outros AINEs, o ibuprofeno pode produzir aumentos ligeiros e transitórios em alguns parâmetros hepáticos, bem como aumentos significativos das transaminases (SGOT e SGPT). Caso se verifique um aumento significativo destes parâmetros, o tratamento deve ser descontinuado (ver secções 4.2 e 4.3).

Mascaramento dos sintomas de infeções subjacentes

O ibuprofeno pode mascarar os sintomas de infeção, o que pode levar a um atraso no início do tratamento adequado e, consequentemente, a um agravamento da evolução da infeção. Isto foi observado na pneumonia bacteriana adquirida na comunidade e em complicações bacterianas relacionadas com a varicela. Quando Brufen é administrado para o alívio da febre ou da dor associadas a uma infeção, recomenda-se a monitorização da infeção. Em situações não hospitalares, o doente deve consultar um médico em caso de persistência ou agravamento dos sintomas.

Idosos

Os idosos têm uma maior frequência de reações adversas aos AINEs, especialmente hemorragia e perfuração gastrointestinal, que podem ser fatais (ver secção 4.2).

Outros

Tal como acontece com outros AINEs, também podem ocorrer reações alérgicas, como reações anafiláticas/anafilactoides, sem exposição prévia ao medicamento. As reações de hipersensibilidade agudas graves (por exemplo choque anafilático) foram observadas muito raramente. Aos primeiros sinais de reação de hipersensibilidade após a toma de ibuprofeno, a terapêutica deve ser interrompida. Devem ser iniciadas as medidas médicas necessárias, de acordo com os sintomas, por profissionais especializados.

Doenças respiratórias

Pode precipitar-se um broncoespasmo em doentes com sintomatologia ou antecedentes de asma brônquica ou doença alérgica (ver secção 4.3).

LES e doença mista do tecido conjuntivo

Foram observados casos de meningite asséptica em raras ocasiões, em doentes em terapêutica com ibuprofeno. Embora a probabilidade de ocorrência seja maior em doentes com lúpus eritematoso sistémico (LES) e afeções relacionadas com os tecidos conjuntivos, foram observados casos em doentes sem doença crónica subjacente, pelo que deve ser tida em consideração se o medicamento for administrado (ver secção 4.8).

População pediátrica

Existe o risco de insuficiência renal em crianças e adolescentes desidratados.

Outros AINEs

Deve evitar-se a utilização de ibuprofeno com AINEs concomitantes, incluindo inibidores seletivos da ciclooxigenase-2 (ver secção 4.5).

Em doentes submetidos a tratamento de longa duração com ibuprofeno, a função renal, a função hepática, a função hematológica e os hemogramas devem ser monitorizados como medida de precaução.

É necessária uma monitorização médica especial durante a administração em doentes imediatamente após uma cirurgia *major*.

Durante o tratamento de longa duração com doses elevadas de analgésicos, podem ocorrer cefaleias que não devem ser tratadas com doses mais elevadas do medicamento.

Exceccionalmente, a varicela pode ser a origem de infeções cutâneas graves e complicações nos tecidos moles. Até ao momento, o papel dos AINEs no agravamento destas infeções não pode ser excluído. Por conseguinte, a administração de ibuprofeno deve ser evitada em caso de varicela.

O ibuprofeno só deve ser utilizado após uma avaliação risco/benefício rigorosa em doentes com porfíria intermitente aguda.

O consumo concomitante de álcool com AINEs, incluindo ibuprofeno, pode aumentar o risco de efeitos adversos no trato gastrointestinal, como hemorragia GI ou no sistema nervoso central, possivelmente devido a um efeito aditivo.

Advertências relativas aos excipientes

Este medicamento contém menos do que 1 mmol (39 mg) de potássio por cápsula, ou seja, é praticamente “isento de potássio”.

Este medicamento contém 72,4 mg de sorbitol (sob a forma de sorbitol, líquido, parcialmente desidratado) em cada cápsula, o que equivale a 1,03 mg/kg.

Interações com testes de diagnóstico

- Tempo de hemorragia (pode prolongar-se por 1 dia após a interrupção do tratamento).
- Concentração de glicemia (pode diminuir).
- Depuração da creatinina (pode diminuir).
- Testes cutâneos com alérgenos.
- Hematócrito ou hemoglobina (podem diminuir).
- Concentrações sanguíneas de azoto ureico e concentrações séricas de creatinina e potássio (podem aumentar).
- Com testes de função hepática: aumento dos valores das transaminases.

4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação

Em geral, os AINEs devem ser utilizados com precaução quando em conjunto com outros medicamentos que possam aumentar o risco de ulceração gastrointestinal, hemorragia gastrointestinal ou disfunção renal.

O ibuprofeno deve ser evitado em associação com:

- ácido acetilsalicílico: a administração concomitante de ibuprofeno e ácido acetilsalicílico não é normalmente recomendada devido ao potencial aumento de reações adversas.
- Os dados experimentais sugerem que o ibuprofeno pode inibir de forma competitiva o efeito da baixa dose de ácido acetilsalicílico na agregação de plaquetas quando prescritos concomitantemente. Embora haja incertezas relativamente à extrapolação destes dados para a prática clínica, a possibilidade de que a utilização normal de longa duração de ibuprofeno possa reduzir o efeito cardioprotetor da dose baixa de ácido acetilsalicílico não pode ser excluída. Não é considerado

provável nenhum efeito clinicamente relevante no caso da utilização ocasional de ibuprofeno (ver secção 5.1);

- outros AINEs, incluindo inibidores seletivos da ciclooxigenase-2: evite a utilização concomitante de dois ou mais AINEs (incluindo o ácido acetilsalicílico) dado que pode resultar num aumento do risco de reações adversas (ver secção 4.4).

O ibuprofeno deve ser utilizado com precaução em associação com:

- *medicamentos anti-agregantes plaquetários e inibidores seletivos da recaptção da serotonina (ISRS)*: aumento do risco de hemorragia gastrointestinal (ver secção 4.4). Os AINEs não devem ser associados a ticlopidina devido ao risco de um efeito aditivo na inibição da função das plaquetas;
- *anticoagulantes*: os AINEs podem aumentar os efeitos dos anticoagulantes, tais como a varfarina (ver secção 4.4);
- *mifepristona*: os AINEs não devem ser administrados no prazo de 8 a 12 dias após a administração de mifepristona dado que podem reduzir os efeitos da mifepristona;
- *hidantoínas e sulfonamidas*: os efeitos tóxicos destas substâncias podem ser aumentados. Os níveis plasmáticos de fenitoína podem aumentar durante o tratamento simultâneo com ibuprofeno;
- *lítio*: os AINEs podem aumentar os níveis plasmáticos de lítio, possivelmente através da redução da depuração renal. A administração concomitante deve ser evitada, a menos que os níveis de lítio sejam monitorizados. Deve considerar-se a redução da dose de lítio;
- *metotrexato administrado em doses de 15 mg/semana ou superiores*: se os AINEs e o metotrexato forem administrados num intervalo de 24 horas, pode ocorrer um aumento dos níveis plasmáticos de metotrexato (parece que a depuração renal pode ser reduzida pelo efeito dos AINEs), com consequente aumento do risco de toxicidade do metotrexato. A utilização de ibuprofeno deve, por conseguinte, ser evitada em doentes que estejam a receber tratamento com metotrexato em doses elevadas;
- *metotrexato administrado em doses baixas, inferiores a 15 mg/semana*: o ibuprofeno aumenta os níveis de metotrexato. Quando utilizado em associação com metotrexato em doses baixas, os valores sanguíneos do doente devem ser cuidadosamente monitorizados, especialmente durante as primeiras semanas de administração simultânea. Também será necessário um aumento da monitorização em caso de deterioração da função renal, mesmo que ligeira, e em doentes idosos, bem como a monitorização da função renal para prevenir uma possível redução da depuração do metotrexato;
- *glicosídeos cardíacos (digoxina)*: os AINEs podem exacerbar a insuficiência cardíaca, reduzir a TFG e aumentar os níveis plasmáticos de glicosídeos. Os AINEs podem aumentar os níveis plasmáticos de digoxina, aumentando assim o risco de toxicidade da digoxina;
- *pentoxifilina*: em doentes que recebem tratamento com ibuprofeno em associação com pentoxifilina, o risco de hemorragia pode aumentar, pelo que se recomenda a monitorização do tempo de hemorragia;
- *probenecida e sulfínpirazona*: podem causar um aumento das concentrações plasmáticas de ibuprofeno. Esta interação pode ser devida a um mecanismo inibitório no local da secreção tubular renal e da glucuronoconjugação, e pode implicar um ajuste da dose de ibuprofeno;
- *antibióticos da classe das quinolonas*: os dados de animais indicam que os AINEs podem aumentar o risco de convulsões associadas a antibióticos da classe das quinolonas. Os doentes que tomam AINEs e quinolonas podem estar em maior risco de desenvolver convulsões;
- *tiazidas, substâncias relacionadas com as tiazidas, diuréticos da ansa e diuréticos poupadores de potássio*: os AINEs podem neutralizar o efeito diurético destes medicamentos. A utilização simultânea de um AINE e um diurético pode aumentar o risco de nefrotoxicidade, causada pelos AINEs, em resultado da redução do fluxo sanguíneo renal. Tal como acontece com outros AINEs, o tratamento concomitante com diuréticos poupadores de potássio pode estar associado a um aumento dos níveis de potássio, sendo, por isso, necessário monitorizar os níveis plasmáticos deste ião;
- *sulfonilureias*: os AINEs podem potenciar o efeito hipoglicémico das sulfonilureias, deslocando a sua ligação às proteínas plasmáticas. Pode ser necessário um ajuste de dose.
- *ciclosporina, tacrolimus*: a sua administração simultânea com AINEs pode aumentar o risco de nefrotoxicidade devido à redução da síntese renal de prostaglandinas. Se administrados concomitantemente, a função renal deve ser cuidadosamente monitorizada;
- *anti-hipertensores (inibidores da ECA e antagonistas da angiotensina II) e diuréticos*: dado que os AINEs podem diminuir os efeitos destes medicamentos. Em alguns doentes com insuficiência renal (por exemplo, doentes desidratados ou doentes idosos com comprometimento da função renal), a co-administração de um inibidor da ECA ou antagonista da angiotensina-II e agentes inibidores da ciclooxigenase pode resultar na deterioração da função renal, incluindo a possibilidade de

insuficiência renal aguda, que é normalmente reversível. Estas interações devem ser consideradas em doentes que tomam um coxib concomitantemente com inibidores da ECA ou antagonistas da angiotensina II. Assim, esta combinação deve ser administrada com precaução, especialmente nos idosos. Os doentes devem ser adequadamente hidratados e deverá ser analisada a necessidade de monitorizar a função renal após o início da terapêutica concomitante, e periodicamente desde então. Os diuréticos podem aumentar o risco de nefrotoxicidade dos AINEs;

- *trombolíticos*: podem aumentar o risco de hemorragia;
- *zidovudina*: aumento do risco de toxicidade hematológica quando os AINEs são administrados com zidovudina. Existem evidências de um aumento do risco de hemartrose e hematoma em doentes hemofílicos VIH (+) a receber tratamento concomitante com zidovudina e ibuprofeno;
- *aminoglicosídeos*: os AINEs podem diminuir a excreção de aminoglicosídeos;
- *extratos de ervas*: o ginkgo biloba pode potenciar o risco de hemorragia com AINEs;
- *corticosteroides*: aumento do risco de hemorragia ou ulceração GI (ver secção 4.4);
- *medicamentos anti-agregantes plaquetários e inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS)*: podem aumentar o risco de hemorragia gastrointestinal (ver secção 4.4);
- *alimentos*: a administração de ibuprofeno juntamente com alimentos diminui a velocidade de absorção (ver secção 5.2);
- *baclofeno*: o ibuprofeno pode aumentar a toxicidade do baclofeno, devido à possível acumulação causada por insuficiência renal provocada pelo ibuprofeno;
- *resinas de troca iónica*: a administração de ibuprofeno com resinas de troca iónica (colestiramina) produz uma diminuição da absorção do ibuprofeno, com possível diminuição do seu efeito, ao fixar o medicamento nos pontos aniónicos da resina;
- *tacrina*: a administração de ibuprofeno em conjunto com tacrina produz um aumento da toxicidade da tacrina, com episódios de delírio, devido à possível deslocação da sua ligação às proteínas plasmáticas;
- *inibidores do CYP2C9*: a administração concomitante de ibuprofeno e inibidores do CYP2C9 pode aumentar a exposição ao ibuprofeno (substrato do CYP2C9). Num estudo com voriconazol e fluconazol (inibidores do CYP2C9), foi demonstrado um aumento da exposição ao ibuprofeno S(+) de aproximadamente 80% a 100%. Deve considerar-se a redução da dose de ibuprofeno com a administração concomitante de inibidores do CYP2C9 fortes, particularmente quando são administradas doses elevadas de ibuprofeno com voriconazol ou fluconazol.

4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento

Gravidez

A inibição da síntese de prostaglandinas pode afetar negativamente a gravidez e/ou o desenvolvimento do embrião/feto. Os dados de estudos epidemiológicos sugerem um aumento do risco de aborto e de malformação cardíaca e gastrosquise após a utilização de um inibidor da síntese de prostaglandinas no início da gravidez. O risco absoluto de malformação cardiovascular aumentou de menos de 1% para aproximadamente 1,5%. Acredita-se que o risco aumenta com a dose e com a duração da terapêutica.

Em animais, a administração de um inibidor da síntese de prostaglandinas demonstrou um aumento das perdas pré e pós-implantação e letalidade embrio/fetal. Além disso, foram observadas mais evidências de várias malformações, incluindo cardiovasculares, em animais que receberam um inibidor da síntese de prostaglandinas durante o período organogenético.

A partir da 20.^a semana de gravidez, a utilização de ibuprofeno pode causar oligohidrâmnio resultante de uma disfunção renal fetal. Este estado pode ocorrer logo após o início do tratamento e, geralmente, é reversível após a descontinuação do tratamento. Além disso, foram notificados casos de constrição do canal arterial após o tratamento no segundo trimestre, a maioria dos quais com resolução após a interrupção do tratamento. Por conseguinte, durante o primeiro e segundo trimestres de gravidez, o ibuprofeno não deve ser tomado a menos que seja claramente necessário. Se for utilizado ibuprofeno por uma mulher que esteja a tentar engravidar, ou durante o primeiro e o segundo trimestres de gravidez, a dose deve ser mantida o mais baixa possível, tal como a duração do tratamento. Deve ser considerada uma monitorização pré-natal relativamente a oligohidrâmnio e constrição do canal arterial após uma exposição a ibuprofeno durante vários dias a partir da 20.^a semana de gestação. O tratamento com ibuprofeno deve ser descontinuado se for detetado oligohidrâmnio ou uma constrição do canal arterial.

Durante o terceiro trimestre de gravidez, todos os inibidores da síntese de prostaglandinas podem expor o feto, a:

- toxicidade cardiopulmonar (constrição/fecho prematuro do canal arterial e hipertensão pulmonar);
- disfunção renal (ver acima);

A mãe e o recém-nascido no final da gravidez, a:

- possível prolongamento do tempo de hemorragia, um efeito antiagregante que pode ocorrer mesmo em doses muito baixas;
- inibição das contrações uterinas resultando em atraso do trabalho de parto ou prolongamento deste.

Consequentemente, o ibuprofeno está contraindicado durante o último trimestre de gravidez (ver secções 4.3 e 5.3).

Amamentação

O ibuprofeno e os seus metabolitos podem aparecer no leite materno em concentrações muito baixas. Não são conhecidos efeitos nefastos para os bebés, pelo que não é necessário interromper a amamentação em tratamentos de curta duração, nas doses recomendadas para dor e febre ligeiras ou moderadas.

Fertilidade

Existem algumas evidências de que os medicamentos que inibem a síntese da ciclooxigenase/prostaglandina podem causar comprometimento da fertilidade feminina por meio de um efeito na ovulação e não são recomendados para mulheres que estão a tentar engravidar. Tal é reversível após a descontinuação do tratamento.

Se o ibuprofeno for utilizado por mulheres que desejam engravidar, devem ser utilizadas as doses mais baixas pelo período de tempo mais curto possível. Em mulheres com dificuldade em engravidar ou a realizar exames de fertilidade, deve considerar-se a descontinuação deste medicamento.

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas

Se for administrada uma dose única de ibuprofeno ou durante um curto período de tempo, Brufen 400 mg cápsulas moles não tem influência ou tem uma influência negligenciável sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas.

Os doentes que apresentarem tonturas, vertigens, perturbações visuais ou outras perturbações do sistema nervoso central durante o tratamento com ibuprofeno devem evitar conduzir ou operar máquinas.

4.8 Efeitos indesejáveis

A seguinte lista de efeitos adversos abrange todas as reações adversas conhecidas do tratamento com ibuprofeno, inclusive em doses elevadas e em terapêutica de longa duração em doentes com reumatismo. As frequências estabelecidas, que vão além de notificações muito raras, referem-se à utilização de curta duração de doses diárias de até um máximo de 1200 mg de ibuprofeno para formas farmacêuticas orais.

Deve ter-se em atenção que os seguintes efeitos adversos são predominantemente dependentes da dose e variam entre os indivíduos.

Os acontecimentos adversos observados são frequentemente gastrointestinais.

Podem ocorrer úlceras pépticas, perfuração ou hemorragia gastrointestinal, em alguns casos fatais, especialmente em doentes idosos (ver secção 4.4).

Foi também notificada a ocorrência de náuseas, vômitos, diarreia, flatulência, obstipação, dispepsia, dor abdominal, melena, hematémese, estomatite ulcerosa, exacerbação de colite e doença de Crohn (ver secção 4.4). A ocorrência de gastrite foi observada com menos frequência.

Foram notificados casos de edema, hipertensão e insuficiência cardíaca associados ao tratamento com AINEs.

Estudos clínicos sugerem que a utilização de ibuprofeno, especialmente em doses elevadas (2400 mg/dia), poderá estar associada a um pequeno aumento do risco de acontecimentos trombóticos arteriais (por exemplo enfarte do miocárdio ou AVC) (ver secção 4.4).

A exacerbação da inflamação relacionada com uma infeção (por exemplo desenvolvimento de fasciite necrotizante) foi descrita como coincidente com a administração de AINEs. Está possivelmente associada ao mecanismo de ação destes medicamentos.

Os acontecimentos adversos que têm sido associados ao ibuprofeno são apresentados abaixo, listados por classe de sistemas de órgãos e frequência. As frequências são definidas como: muito frequentes ($\geq 1/10$); frequentes ($\geq 1/100$, $< 1/10$); pouco frequentes ($\geq 1/1000$, $< 1/100$); raros ($\geq 1/10\,000$, $< 1/1000$); muito raros ($< 1/10\,000$) e desconhecida (a frequência não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis). Em cada grupo de frequência, os acontecimentos adversos são apresentados por ordem decrescente de gravidade.

Classes de sistemas de órgãos	Frequência	Acontecimento adverso
Infeções e infestações	Muito raros	Foi descrita inflamação aguda relacionada com uma infeção (por exemplo, desenvolvimento de fasciite necrotizante). Excecionalmente, durante uma infeção por varicela, podem ocorrer infeções cutâneas graves e complicações tecidulares.
Doenças do sangue e do sistema linfático	Muito raros	Perturbações hematopoiéticas (anemia, leucopenia, trombocitopenia, pancitopenia, agranulocitose). Os primeiros sinais são: febre, dor de garganta, úlceras superficiais da boca, sintomas gripais, exaustão extrema, hemorragias e nódos negros sem explicação. Nestes casos, o doente deve ser aconselhado a interromper o tratamento com este medicamento, a evitar a automedicação com analgésicos ou antipiréticos e a consultar um médico.
Perturbações do foro psiquiátrico	Muito raros	Reações psicóticas, depressão.
Doenças do sistema imunitário		Reações de hipersensibilidade consistindo em ¹ :
	Pouco frequentes	Urticária e prurido
	Muito raros	Reações de hipersensibilidade graves. Os sintomas podem incluir: edema facial, inchaço da língua, inchaço interno da laringe com constrição das vias respiratórias, dispneia, taquicardia, hipotensão (anafilaxia, angioedema ou choque grave). Exacerbação da asma.
	Desconhecida	Reatividade do trato respiratório, incluindo asma, broncoespasmo e dispneia.
Sistema nervoso	Desconhecida	Cefaleias, tonturas, insónias, agitação, irritabilidade ou cansaço.
	Muito raros	Meningite assética ²
Afeções oculares	Pouco frequentes	Perturbações visuais
Afeções do ouvido e do labirinto	Raros	Acufenos
Cardiopatias	Muito raros	Insuficiência cardíaca, palpitações e edema, enfarte do miocárdio.
	Desconhecida	Síndrome de Kounis
Vasculopatias	Muito raros	Hipertensão, vasculite
Doenças gastrointestinais	Frequentes	Sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, náuseas e dispepsia. Diarreia, flatulência, obstipação, azia, vómitos e

		pequenas perdas de sangue que, em casos excepcionais, podem causar anemia.
	Pouco frequentes	Úlceras gastrointestinais, hemorragia ou perfuração gastrointestinal. Estomatite ulcerosa, exacerbação da colite e doença de Crohn (ver secção 4.4), gastrite
	Muito raros	Esofagite e formação de estenose intestinal do tipo diafragma, pancreatite.
Afeções hepatobiliares	Muito raros	Disfunção hepática, lesões hepáticas, especialmente durante o tratamento de longa duração, insuficiência hepática, hepatite aguda
Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos	Pouco frequentes	Várias erupções cutâneas
	Muito raros	Reações adversas cutâneas graves (RACG) (incluindo síndrome de Stevens-Johnson, eritema multiforme, dermatite esfoliativa e necrólise epidérmica tóxica). Alopecia.
	Desconhecida	Reação a fármacos com eosinofilia e sintomas sistémicos (síndrome DRESS), pustulose exantematosa generalizada aguda (PEGA) Reações de fotossensibilidade.
Doenças renais e urinárias	Raros	Lesões nas estruturas renais (necrose papilar) e aumento da concentração de ureia no sangue.
	Muito raros	Formação de edema, particularmente em doentes com pressão arterial alta ou insuficiência renal, síndrome nefrótica ou nefrite intersticial, que pode ser acompanhada por insuficiência renal aguda.
Exames complementares de diagnóstico	Raros	Diminuição dos níveis de hemoglobina

¹ Foram observadas reações de hipersensibilidade após o tratamento com ibuprofeno. Estas podem consistir em (a) reações alérgicas não específicas e anafilaxia, (b) atividade do trato respiratório incluindo asma, asma agravada, broncospasmo, dispneia, ou (c) doenças cutâneas variadas, incluindo erupções de vários tipos, prurido, urticária, púrpura, angioedema e, mais raramente, dermatoses esfoliativa e bolhosa (incluindo necrólise epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson e eritema multiforme).

² O mecanismo patogénico da meningite asséptica induzida por medicamentos não é totalmente conhecido. No entanto, os dados disponíveis sobre meningite asséptica relacionada com AINEs apontam para uma reação de hipersensibilidade (devido a uma relação temporal com a ingestão deste medicamento e o desaparecimento dos sintomas após a descontinuação do medicamento). É importante referir que foram observados casos isolados de sintomas de meningite asséptica (como rigidez do pescoço, cefaleias, náuseas, vômitos, febre ou desorientação) durante o tratamento com ibuprofeno, em doentes com doenças autoimunes pré-existentes (como lúpus eritematoso sistémico, doença mista do tecido conjuntivo).

Notificação de suspeitas de reações adversas

A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas diretamente ao INFARMED, I.P.:

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram>

(preferencialmente)

ou através dos seguintes contactos:

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

4.9 Sobredosagem

A maioria dos casos de sobredosagem foi assintomática. Existe risco de sintomatologia com doses superiores a 80-100 mg/kg de ibuprofeno.

O início dos sintomas por sobredosagem ocorre geralmente no prazo de 4 horas. Os sintomas mais frequentes são ligeiros e incluem dor abdominal, náuseas, vômitos, letargia, sonolência, cefaleias, nistagmo, acufenos e ataxia. Raramente surgiram sintomas moderados ou graves, como hemorragia gastrointestinal, hipotensão, hipotermia, acidose metabólica, convulsões, alteração da função renal, coma, dispneia/síndrome de dispneia aguda do adulto e episódios transitórios de apneia (em crianças após a ingestão de grandes quantidades).

Em caso de intoxicação grave, pode ocorrer acidose metabólica.

A utilização prolongada de doses superiores às recomendadas ou a sobredosagem podem resultar em acidose tubular renal e hipocalcemia.

Tratamento

O tratamento deve ser sintomático e de suporte e incluir a manutenção das vias respiratórias desobstruídas e a monitorização dos sinais cardíacos e vitais até à estabilização. Não existe nenhum antídoto específico disponível. Para quantidades que provavelmente não produzirão sintomas (menos de 50 mg/kg de ibuprofeno), pode ser administrada água para minimizar o desconforto gastrointestinal.

Considere a administração oral de carvão ativado se o doente apresentar sintomas no prazo de 1 hora após a ingestão de uma quantidade potencialmente tóxica. O esvaziamento do estômago por emese só deve ser considerado durante os 60 minutos após a ingestão. Assim, a lavagem gástrica não deve ser considerada, a menos que o doente tenha ingerido uma quantidade de medicamento que represente risco de vida e não tenham decorrido mais de 60 minutos desde a ingestão do medicamento.

O benefício de medidas como diurese forçada, hemodiálise ou hemoperfusão é duvidoso, uma vez que o ibuprofeno se liga intensamente às proteínas plasmáticas.

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propriedades farmacodinâmicas

Grupo farmacoterapêutico: 9.1.3 – Aparelho locomotor, Anti-inflamatórios não esteroides: Derivados do ácido propiónico. Código ATC: M01AE01

Mecanismo de ação

O ibuprofeno é um fármaco anti-inflamatório não esteroide (AINE), com propriedades analgésicas e antipiréticas, que atua por inibição da síntese de prostaglandinas, através da inibição competitiva e reversível das várias isoformas da ciclooxigenase (COX), a nível periférico e no sistema nervoso central.

O efeito analgésico dos AINEs está relacionado com a inibição da produção excessiva de prostaglandinas (PG). Estas parecem ter um efeito sensibilizador significativo nas terminações nociceptivas ao nível periférico, aumentando o efeito algogénico da bradicinina. Ao nível central, o ibuprofeno é capaz de inibir a síntese da COX-3, considerada a fração catalítica da COX-1, sendo a isoforma mais comum das PG no sistema nervoso central.

A ação anti-inflamatória também está relacionada com a inibição da síntese de prostaglandinas, uma vez que a resposta inflamatória é sempre acompanhada pela libertação de vários prostanoídes, com poderosas propriedades vasodilatadoras, que provocam o aumento do calibre das arteríolas pré-capilares, levando à típica cor vermelha da pele correspondente às áreas inflamadas. Além disso, aumentam o efeito da bradicinina e da histamina na permeabilidade vascular, favorecendo a formação do edema inflamatório característico.

A ação antipirética está relacionada com a inibição da síntese de PGE_1 no hipotálamo.

Além disso, o ibuprofeno inibe reversivelmente a agregação de plaquetas.

Os dados experimentais sugerem que o ibuprofeno pode inibir, por competição, o efeito de uma dose baixa de ácido acetilsalicílico na agregação das plaquetas quando estes medicamentos são administrados concomitantemente. Alguns estudos farmacodinâmicos demonstram que, quando tomadas doses unitárias de ibuprofeno 400 mg até 8 horas antes ou no prazo de 30 minutos após a administração de ácido acetilsalicílico de libertação imediata (81 mg), ocorreu uma diminuição do efeito de ácido acetilsalicílico na formação de tromboxano ou na agregação das plaquetas. Embora existam incertezas relativamente à extrapolação destes dados para uma situação clínica, a possibilidade de que a utilização normal de longa duração de ibuprofeno possa reduzir o efeito cardioprotetor da dose baixa de ácido acetilsalicílico não pode ser excluída. Não é considerado provável que ocorram efeitos clinicamente relevantes com a utilização ocasional de ibuprofeno (ver secção 4.5).

5.2 Propriedades farmacocinéticas

O ibuprofeno é um medicamento com farmacocinética linear.

Absorção

Brufen consiste em 400 mg de ibuprofeno dissolvido num solvente hidrofílico numa cápsula de gelatina. Após a ingestão, a cápsula de gelatina desintegram-se nos sucos gástricos, libertando imediatamente o ibuprofeno solubilizado para absorção. A concentração plasmática máxima mediana é atingida em aproximadamente 30 minutos após a administração, quando tomado com o estômago vazio.

Um estudo farmacocinético demonstrou que a concentração plasmática máxima média foi atingida mais rapidamente com 1 cápsula líquida de 400 mg de ibuprofeno (32,5 minutos) do que com 2 comprimidos de 200 mg de ibuprofeno (90 minutos). Este estudo também demonstrou que o ibuprofeno na cápsula líquida tem a mesma taxa de absorção que os comprimidos, pelo que os dois medicamentos são considerados terapeuticamente equivalentes.

Quando tomado com alimentos, os níveis plasmáticos máximos podem ser retardados.

Eliminação

A semivida de eliminação plasmática é de aproximadamente 2 horas.

O ibuprofeno é metabolizado no fígado em dois metabolitos, que não têm atividade farmacológica. O ibuprofeno e os seus metabolitos são parcialmente conjugados com ácido glucurónico. É eliminado principalmente pelos rins e pela urina, 90% sob a forma de metabolitos inativos conjugados com ácido glucurónico e 10% sob a forma inalterada. A excreção do medicamento está praticamente completa 24 horas após a última dose administrada.

5.3 Dados de segurança pré-clínica

A toxicidade subcrónica e crónica do ibuprofeno em experiências com animais manifestou-se principalmente sob a forma de lesões e ulcerações do trato gastrointestinal.

Estudos *in vitro* e *in vivo* não revelaram evidências clinicamente relevantes de efeitos mutagénicos do ibuprofeno. Em estudos em ratos e ratinhos, não foram encontradas evidências de efeitos carcinogénicos do ibuprofeno.

O ibuprofeno levou à inibição da ovulação em coelhos e prejudicou a implantação em várias espécies animais (coelhos, ratos, ratinhos). Estudos experimentais em ratos e coelhos demonstraram que o ibuprofeno atravessa a placenta. Após a administração de doses tóxicas maternas, verificou-se um aumento da incidência de malformações (defeitos do septo ventricular) nos descendentes de ratos.

Estudos de avaliação de risco ambiental demonstraram que o ibuprofeno pode representar um risco para o compartimento aquático, especialmente para os peixes.

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

6.1 Lista dos excipientes

Enchimento da cápsula

Macrogol 600

Hidróxido de potássio (E525)

Água purificada

Invólucro da cápsula

Gelatina (E441)

Sorbitol, líquido, parcialmente desidratado (E420)

Água purificada

6.2 Incompatibilidades

Não aplicável.

6.3 Prazo de validade

2 anos.

6.4 Precauções especiais de conservação

Conservar a uma temperatura inferior a 30 °C.

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente

Brufen é fornecido em blisters.

Blisters

Embalagem branca opaca de PVC/PVdC/Al.

Embalagem com 10, 12, 15, 20 cápsulas moles.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

6.6 Precauções especiais de eliminação

Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências locais.

Este medicamento pode representar um risco para o ambiente (ver secção 5.3).

7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Viatrix Healthcare, Lda.

Av. D. João II, Edifício Atlantis, N.º 44C - 7.3 e 7.4

1990-095 Lisboa

8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Registo nº xxxxxxxx no INFARMED, I.P. – 20 cápsulas moles, 400 mg, blisters de PVC/PVdC/Al

9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Data da primeira autorização:

10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO